

Pflege konkret. Chirurgie, Orthopädie, Urologie. 6 Auflage

12.4.1

Pflege bei suprapubischer Blasenpunktion und -drainage

DEFINITION

Suprapubische Blasenpunktion : Punktion der gefüllten Harnblase durch die Bauchdecke hindurch.

Suprapubischer Blasenkatheter (*suprapubische Blasendrainage, suprapubische Blasenfistel, Zystostomie, Pufi*): Harnableitung über einen Kunststoffkatheter, der durch die Bauchhaut in die Blase eingeführt wird. Heute in der Regel Katheter mit gerader Spitze und Möglichkeit zur Blockung in der Blase ([Abb. 12.17](#)).

Die **Blasenpunktion** und Anlage eines **suprapubischen Blasenkatheters** ([Abb. 12.17](#)) sind ärztliche Aufgaben. Pflegende assistieren bei der Punktion bzw. Anlage.

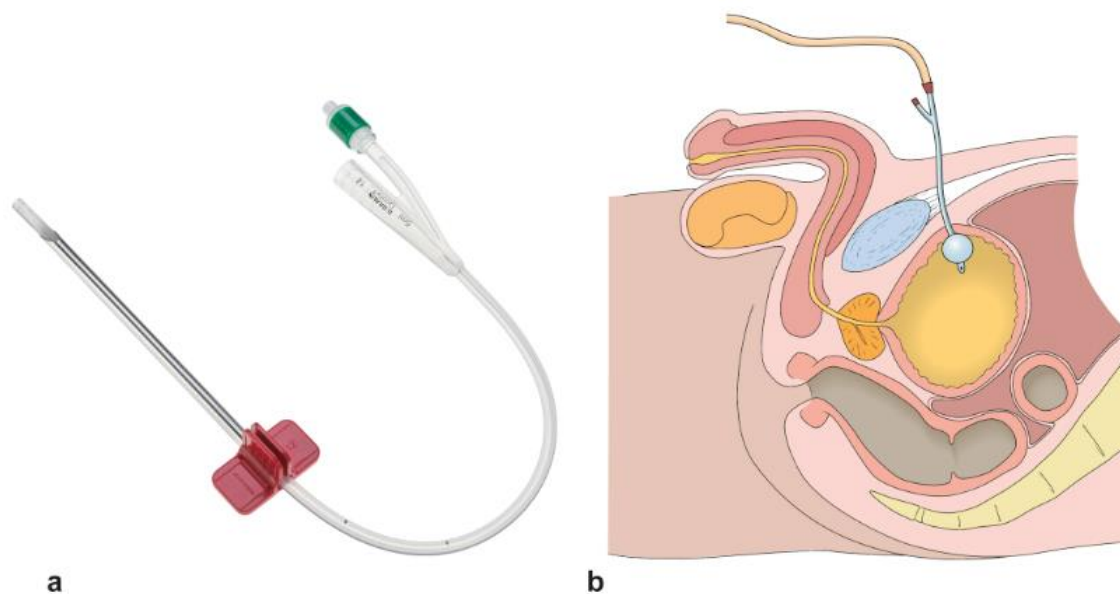


Abb. 12.17

Suprapubischer Blasenkatheter . a) Punktionssatz mit spaltbarer Punktionsskanüle, Blasenkatheter mit Möglichkeit zur Blockung und Katheterstopfen. **b)** Geblockt liegender Blasenkatheter mit zentraler Öffnung.

a) [[U223](#)] b) [[L190](#)]

Indikationen

Diagnostische Indikationen:

- Gewinnung einer sterilen Urinprobe
- Injektion von Kontrastmittel

Therapeutische Indikationen:

- Perioperative Harnableitung bei starker Immobilisation
- Blasenentleerungsstörung
- Harnabflussbehinderung
- Bei kontraindiziertem transurethralen Blasenkatheeter

Vorteile des suprapubischen gegenüber dem transurethralen Blasenkatheeter:

- Keine Verletzungen der Harnröhre mit eventuell nachfolgenden Harnröhrenstrikturen (*Harnröhrenverengungen*)
- Geringere Infektionsrate
- Möglichkeit des Blasen- und Toilettentrainings (suprapubischer Blasenkatheeter stört die Miktion bzw. den Schließmuskel nicht).

Hauptkomplikation der suprapubischen Blasenpunktion sind Blutungen in die Harnblase. Selten sind Verletzungen des Darmes oder abdomineller Gefäße, eventuell mit nachfolgender Peritonitis ([5.9.1](#)), sowie Entzündungen des Punktionskanals oder der Blase.

Pflege

Die Pflegefachpersonen richten die benötigten Materialien. In der Regel kommen fertige Punktionssets (z. B. *Cystofix* ® , *Curity* ®) zum Einsatz. Benötigt werden außerdem eine Lokalanästhesie, ein geschlossenes Urinableitungssystem, sterile Handschuhe, ein steriles Lochtuch.

Vorbereitung des Patienten

Zur Punktion muss die Blase des Patienten gefüllt sein. Deshalb:

- Patienten nach Arzttrücksprache rechtzeitig vor der Punktion reichlich Flüssigkeit (500–1 000 ml Tee oder Mineralwasser) trinken lassen
- Oder bevorzugt Blase über einen bereits liegenden transurethralen Dauerkatheter oder einen zu diesem Zweck gelegten Einmalkatheter retrograd mit 500 ml NaCl-Lösung füllen. Der Einmalkatheter wird nach dem Füllen entfernt, einen liegenden Dauerkatheter abklemmen und belassen, bis der suprapubische Blasenkatheeter korrekt liegt und Urin fördert. Der Arzt kontrolliert die Blasenfüllung unmittelbar vor der Punktion mittels Ultraschall
- Haare am Unterbauch um die geplante Punktionsstelle herum kürzen
- Absetzen von blutverdünnenden Medikamenten
- Patienten flach auf dem Rücken lagern, ggf. Becken durch ein Kissen leicht unterstützen.

Nachsorge

Die Pflegenden schließen das Urinableitungssystem an den Katheter an und bedecken die Punktionsstelle mit einem aseptischen Verband ([Abb. 12.18](#)). Sie achten in den nächsten Stunden auf die Urinausscheidung und v. a. allem auf Durchgängigkeit und Blutbeimengungen.f12-18-9783437257315

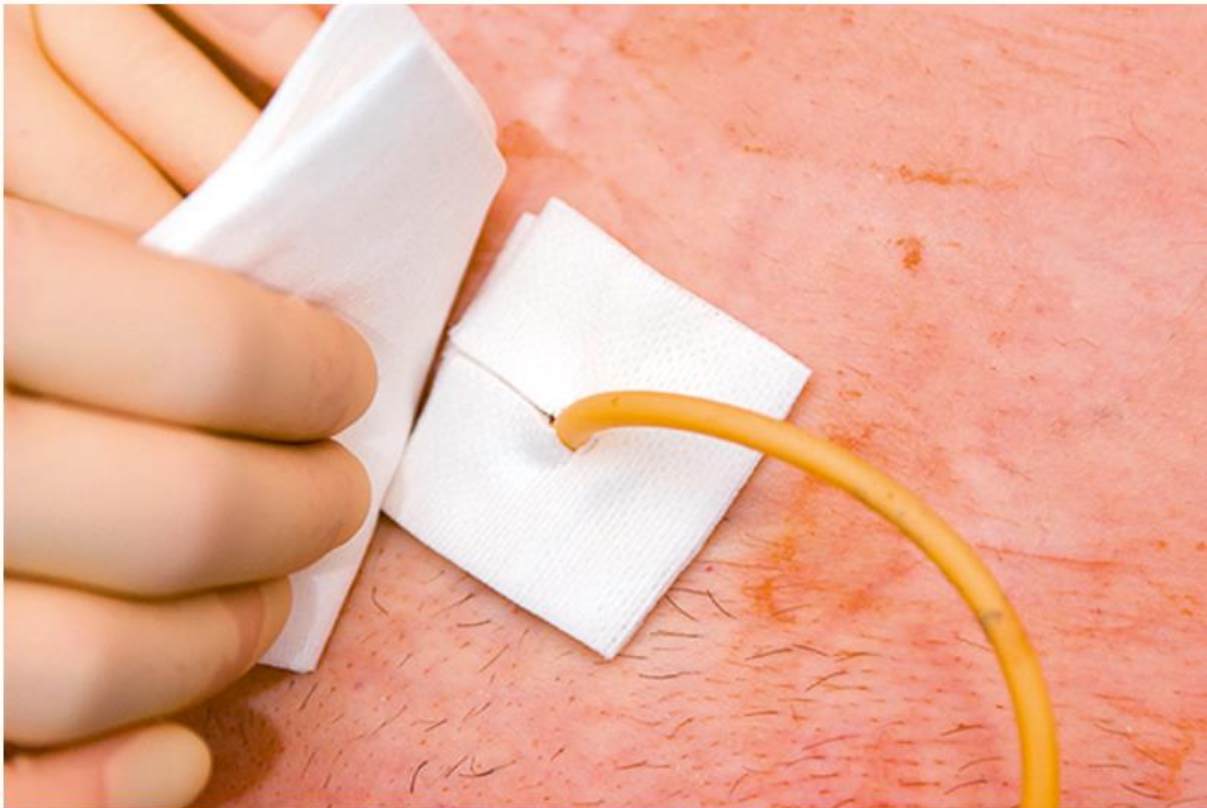


Abb. 12.18

Steriler Verband eines suprapubischen Blasenkatheters (hier ein Katheter, der mittels Ballon in der Blase fixiert ist). Die Pflegenden verwenden Schlitzkompressen und Klebevlies. Die Haare am Unterbauch sind im Bereich des Verbands zu kürzen.

[[K115](#)]

Blasentraining

Für das **Blasentraining** ist der suprapubische Blasenkatheter abgeklemmt. Bei Harndrang entleert der Patient spontan Urin. Danach kontrollieren die Pflegenden die Restharmenge, indem sie den suprapubischen Katheter öffnen und den in der Blase verbliebenen Urin ablaufen lassen. Bei Restharmengen unter 50 ml kann der Katheter meist entfernt werden.

Pflegen. Grundlagen und Interventionen. 3. Auflage

Suprapubischer Blasenkatheterismus

DEFINITION

Suprapubischer (lat. *supra* = über, *os pubis* = Schambein) **Blasenkatheterismus** (suprapubische Drainage, perkutane suprapubische Blasenpunktion, Zystostomie, „Pufi“): Einführen eines Katheters zur Harnableitung durch die Bauchdecke in die Blase.

Die suprapubische Harnableitung ist im Gegensatz zur transurethralen komplikationsärmer, da damit eine geringere Infektionsrate und weniger Verletzungen verbunden sind. [\[19\]](#)

Weitere **Vorteile und Indikationen** für die suprapubische Harnableitung:

- Patient kann trotz liegenden suprapubischen Blasenkatheters Blasen- und Kontinenztraining betreiben
- Intimsphäre wird in höherem Maße gewahrt, da weniger Berührungen im Intimbereich nötig sind
- Wenn eine längere Liegedauer absehbar ist, z. B. bei geriatrischen Patienten
- Harnröhrenverletzungen und -verengungen, die bei einer transurethralen Harnableitung nicht passierbar sind

Absolute Kontraindikationen für die suprapubische Harnableitung sind: [\[14\]](#)

- Blasen- und Abdominaltumoren
- Unzureichend gefüllte Blase (< 200 ml)
- Hauterkrankungen im Punktionsbereich

Relative Kontraindikationen für die suprapubische Harnableitung sind: [\[14\]](#)

- Blutgerinnungsstörungen, Antikoagulation
- Adipositas per magna (BMI > 40)
- Schwangerschaft
- Meteorismus, Ileus
- Thrombopenie
- Vernarbungen, Verbrennungen

Legen eines suprapubischen Blasenkatheters

Das **Legen eines suprapubischen Blasenkatheters** wird von Ärzten in der Regel in der Klinik durchgeführt. Pflegende bereiten den Patienten auf die Maßnahme vor, assistieren bei der Punktion und sind in der Nachbereitung tätig.

Vorbereitung

Der Patient wird über die Maßnahme informiert. Zur Durchführung benötigt der Patient eine gefüllte Blase (mindestens 300 ml), diese kann z. B. mit einer Flüssigkeitsgabe per Infusion erreicht werden. Die gefüllte Blase dient der Sicherheit bei der Punktion, sie verhindert eine Punktion des Peritoneums. Daher sollte der Patient zuvor auch nicht zum Toilettengang aufgefordert werden.

Der Patient liegt flach auf dem Rücken, das Becken kann durch ein Kissen leicht angehoben werden. Störende Kleidung wird entfernt, wobei ein knapper Slip auch angelassen werden kann. Die Haut wird an der Punktionsstelle (1–2 cm oberhalb der Schambeinkante) rasiert oder durch Clipping von Haaren befreit (► [29.2.2](#)).

Pflegende richten zum Legen eines suprapubischen Blasenkatheters folgendes **Material**:

- Hände- und Hautdesinfektionsmittel
- Lokalanästhetikum
- Blasenpunktionsset mit Punktionskanüle und Blasenkatheter
- Steriles Lochtuch, ein Paar sterile Handschuhe
- Skalpell
- Spritze und Aqua dest. zum Blocken, ggf. Nahtmaterial
- Sterile Schlitzkompressen, sterile Kompressen, Pflaster für den Verband
- Geschlossenes Urinableitungssystem
- Abwurf

Durchführung

Die **Durchführung** der suprapubischen Katheterisierung inklusive Wechsel und Entfernung ist eine ärztliche Tätigkeit.

Nach Überprüfung der Blasenfüllung mittels Sonografie, der Haarentfernung und der Desinfektion der mit einem Lochtuch abgedeckten Punktionsstelle punktiert der Arzt die Blase (► [Abb. 19.25](#)). Über die Punktionskanüle schiebt er den Blasenkatheter vor, die Kanüle ist spaltbar und kann so entfernt werden. Dann wird der Katheter mit Aqua dest. geblockt. Die Pflegefachperson verbindet die Punktionsstelle (► [Abb. 19.26](#)).

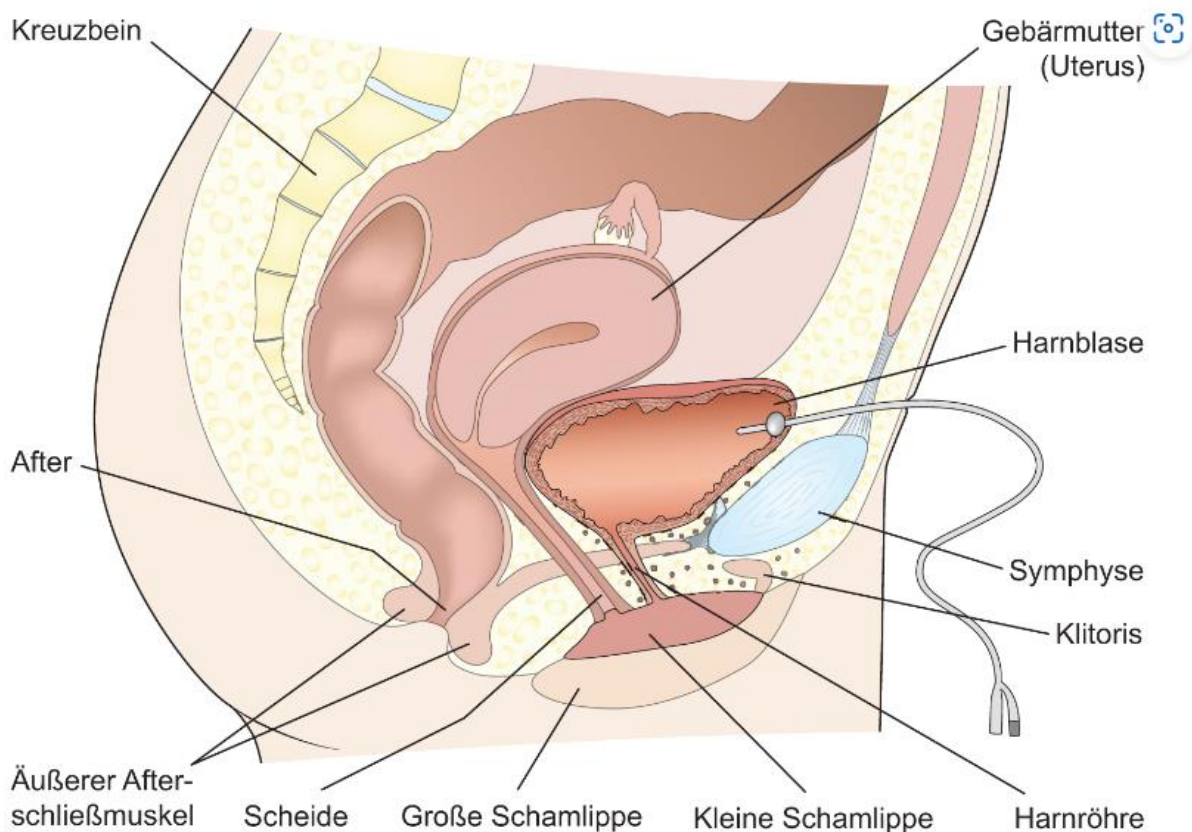


Abb. 19.25
Die korrekte Lage eines suprapubischen Katheters [\[L264\]](#)

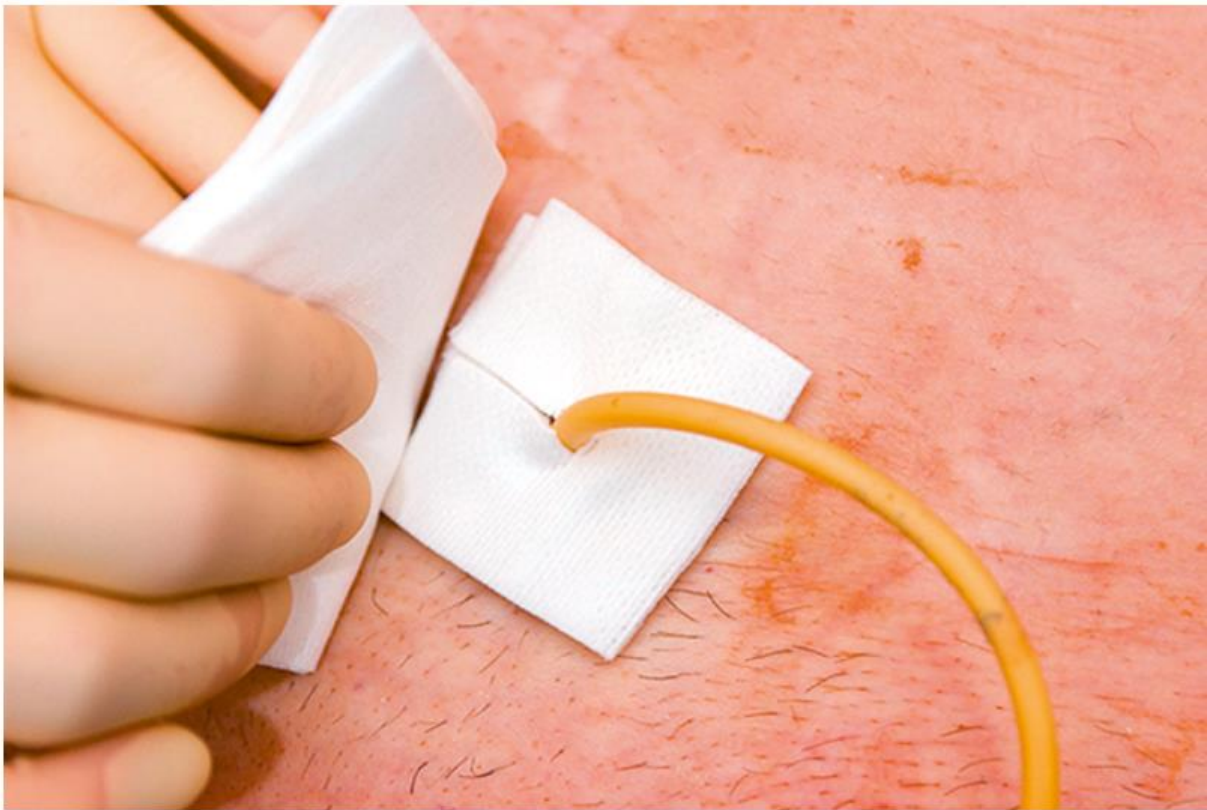


Abb. 12.18

Abb. 19.26

Verbinden der Punktionsstelle/Verbandwechsel. Die Punktionsstelle wird bei Bedarf rasiert (a), dann mit sterilem Handschuh und Tupfern desinfiziert (b), zwei sterile Schlitzkompressen werden überlappend angebracht (c), abschließend wird die Punktionsstelle mit einem Pflaster geschützt (d). [\[K115\]](#)

Nachbereitung

Die **Nachbereitung** umfasst das Ankleiden und die Beobachtung des Patienten sowie das Entsorgen der Materialien. Pflegende überwachen Kreislauftsituation und Urinausscheidung. Abweichungen von den Normwerten (z. B. Veränderung der Farbe oder Beimengungen wie Blut) sind unverzüglich zu melden. Aufgrund der Gefahr einer Peritonitis (Bauchfellentzündung) erheben Pflegende die Schmerzsituation.

Pflege eines liegenden suprapubischen Blasenkatheters

Die Pflege eines liegenden suprapubischen Blasenkatheters entspricht der Pflege eines liegenden transurethralen Blasenkatheters.

Der erste sterile Verbandwechsel (► [Abb. 19.26](#)) erfolgt nach ärztlicher Anordnung. Zunächst wird der Verband täglich, später alle 2–3 Tage gewechselt. Pflegende beobachten die Punktionsstelle auf Rötung, Reizung und Heilung. Patienten können besonders im häuslichen Bereich zum selbstständigen Wechsel des Verbands und zur Pflege des Katheters angeleitet werden.

Zum **Blasentraining** wird der Katheter abgeklemmt. Der Patient kann nun auf physiologischem Weg Wasser lassen. Der in der Blase verbliebene Restharn wird über den Katheter abgelassen und die Menge dokumentiert.

Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Blasenkatheters

Wechseln und Entfernen eines suprapubischen Blasenkatheters sind ärztliche Tätigkeiten. Der Wechsel erfolgt ca. alle 6 Wochen mithilfe spezieller Wechselsets.

Ist der suprapubische Blasenkatheter entfernt worden, wird die Punktionsstelle kurz komprimiert und mit sterilen Kompressen trocken verbunden. Der Verschluss des Punktionskanals erfolgt in den nächsten Tagen von selbst.